

藥局辨識民眾是否可購買緊急事後避孕藥（Emergency Contraceptive Pill, ECP）之評估與轉介流程表

試辦藥品以 LNG（Levonorgestrel）為限。

流程分兩階段：階段一・線上評估（民眾自行上網填寫，於填問卷過程即完成篩選——命中禁忌或須就醫者線上導引就醫、不產生條碼、不必到藥局白跑）→ 階段二・到局現場（本人持 QR Code 到試辦藥局，身分核對後現場評估、供藥）。

三種處置結果：● 不供藥、直接轉介（婦產科 / 醫療院所）● 先供藥 + 衛教 + 轉介或通報（以預防懷孕為第一優先）● 可供藥（完成衛教後交付）

○、制度定位

藥局供藥係「來不及就醫或無法就醫者之替代方案」，非優先途徑。最佳做法仍為由婦產科醫師評估——若民眾來得及就醫，應鼓勵其就醫評估。流程設計與衛教文字不宜使民眾形成「先到藥局、不得已才看婦產科」之順序認知。本節文字應併入衛教單張與線上評估表首頁說明。

一、流程總覽

🇹🇼 完整流程圖請見審議平台「藥局判斷流程圖」頁面：<https://yilingwork.github.io/ecp-trial-scheme/flowchart.html>（瀏覽器開啟即可檢視、可列印）——含檢核步驟 + 結果框、階段一線上 / 階段二藥局分區、醫療與社政轉介分開。

本檔以下各節（二～八）為流程圖各步驟之**詳細判斷準則與衛教清單**；流程圖與本檔為同一套內容之兩種呈現，以 HTML 圖為單一視覺來源。

階段一・線上評估（民眾自行上網填寫，尚未到藥局）

於填問卷過程逐步篩選；命中任一●者，系統線上告知就醫、**不產生購藥條碼**。順序：禁忌 → 懷孕 → 出血 → 時效。

二、❶ 禁忌檢核（仿單禁忌，任一「是」即●不給藥）

#	檢核項目	詢問 / 判斷方式	處置
1	對 LNG 成分過敏	詢問過敏史	● 轉介（本試辦僅 LNG、無替代品項）
2	嚴重肝功能障礙	依國內仿單禁忌詢問病史	● 轉介（禁忌症）。「嚴重肝功能障礙」指肝硬化、肝衰竭、黃疸、腹水；B 肝帶原、輕度肝功能異常、脂肪肝不屬此列、可正常給藥

非禁忌、正常給藥（勿誤擋）：血栓病史（VTE）、子宮外孕**病史**、骨盆腔發炎（PID）均非 LNG 禁忌，正常供藥（對應之加強衛教見階段二 ⑥-8 與「各情境對應之個人化衛教清單」）；子宮外孕僅「疑似急性現症」才轉介。

⚠️ **唯一例外——疑似急性子宮外孕現症**（單側下腹劇痛 + 面色蒼白 + 冒冷汗）→ ● 逕送有婦產科之急診。此非用藥禁忌，而係病人本身為救命外科急症。

三、❷ 懷孕可能性評估（含「3 週驗孕」判準）

僅「有懷孕徵兆 + 3 週前曾無防護性行為」之窄族群才需驗孕，其餘不需驗孕即可給藥。

步驟	詢問 / 判斷方式	處置
① 徵兆	是否有 懷孕徵兆 （週期不規則 / 末次月經已逾週期 / 末次月經不確定〔經量少、週期短〕 / 產後流產後月經未恢復）？	無徵兆 → 續問 ③（ 不需驗孕 ）；有徵兆 → 續下
② 3 週驗孕	有徵兆者再問：距今「 3 週以前 」是否曾有 無防護性行為 ？	否（僅近 3 週內發生）→ 不需驗孕、可給藥 （服用前追加「不排除本次之前懷孕之可能」說明）；是 → 續下（驗孕）
③ 驗孕結果	3 週前曾有性行為者 → 建議使用驗孕棒	陽性（已確診懷孕） → ● 不給藥、轉介婦產科（本藥懷孕用藥分級屬 X 級，已確定懷孕不應使用；並確認懷孕位置、排除子宮外孕、產檢） 陰性 → 續問 ③ 不願驗孕 → ● 供藥（不因不願驗孕而擋藥）+ 下列告知與追蹤

3-1 不願驗孕者之處置

供藥時應完成之告知（納入個人化衛教清單）：

1. 若已確定懷孕，即不應服用本藥；本藥對已成立之懷孕無效，亦無法終止懷孕。
2. 若疑似懷孕，務必注意後續追蹤——可能於本次之前即已受孕而不自知（例如 5 天前曾有不安全性行為、未全程使用保險套），本次又有未保護之性行為而來服藥，惟其實已無效。
3. 月經未按預期時間到來，或出現亂經——此情境仍可供藥，供藥後建議至婦產科就醫確認。
4. 服藥後約 3 週建議驗孕或回診確認避孕成功。

追蹤要求：本試辦及未來正式制度均無強制民眾就醫之權力，經建議轉介者仍可能不就醫。故**必須記錄並追蹤「經建議轉介卻未就醫者」**之後續情況，累積資料供未來政策參考。

四、③ 異常陰道出血評估（兩問法）

步驟	詢問 / 判斷方式	處置
問①	最後一次月經什麼時候？	續下
問②	該次出血與平常月經有無不同（量、天數、顏色）？	續下
判定	不同、說不清楚、或當下正在出血且無法判斷是否為月經	● 不供藥、轉介婦產科查出血原因（排除子宮外孕、子宮內膜病變等，出血鑑別屬醫師專業）；合併疑似子宮外孕急性徵象（單側劇痛、面色蒼白冒冷汗）→ 視為急診
判定	月經正常、無異常出血	續問 ④

五、④ 時效窗口（距最近一次未受保護性行為之時數）

時數	判定	處置
72 小時內	LNG 有效	通過線上篩選（時效題於到場當下再重算）
72—96 小時	LNG off-label、無可靠療效數據	● 轉介、不給藥；72h 後效果未知（國內仿單：24h 95% / 48h 85% / 72h 58% / >72h 未知），逾時線上即導引就醫、不產生條碼
超過 96 小時	LNG 已無效	● / 轉介婦產科評估 UPA（120 小時內） / 含銅子宮內避孕器（5 日內），口頭告知剩餘時數之急迫性

此為「效果」而非「安全」判斷準則。線上初篩逾 96h 即導引就醫、不產生條碼；72h 內者時效題仍須於到場當下重算（防填答與到場之時間差）。通過 ①—④ → 系統產生 QR Code（購藥條碼）+ 顯示附近可購藥之試辦藥局。

階段二・到局現場（本人持 QR Code 至試辦藥局）

六、⑤ 前置確認（到局身分核對）

#	檢核項目	詢問 / 判斷方式	處置
1	本人親領	掃碼調閱線上填答；核對 到場者 = 線上填答者 = 證件本人 （不可代購）	不符 → ● 不供藥
2	個資同意	確認線上已簽署個人資料提供同意書	不符 → ● 不供藥
3	時效重算	時效題以到場當下重算（時數、當下是否出血）；如已逾時或新增出血 → 回 ④ / ③ 對應處置	逾時 / 新增異常 → 依對應步驟

● **不供藥**：不符本人親領要件（代購 / 身分不符）者，本試辦不予供應；得依現行程序至醫療院所就醫取得。（核對相符、仍在時效內 → 續問 ⑥）

七、⑥ 需醫療 / 社政銜接檢核（● 先供藥 + 衛教 + 轉介 / 通報，以預防懷孕為第一優先）

#	檢核項目	處置
1	疑似性暴力 / 性侵害	先供藥；藥師為責任通報人員，依法 113 通報 （單一窗口），由社工介入並陪同至 具社工之醫院 （一站式服務）就醫採證；避免個案重複陳述
2	性傳染病風險（伴侶已知感染、新 / 陌生伴侶且無套、本人有症狀、多重性伴侶）	供藥 + 建議至婦產科接受性病篩檢
3	短期重複使用（如一個月內再次購買）	供藥（重複使用無嚴重安全疑慮，惟月經易紊亂）+ 主動提供常規避孕衛教 + 轉介婦產科 + 納入追蹤
4	哺乳中	供藥 + 衛教（可繼續哺乳；服藥前先哺乳、避免服後馬上哺乳）。 衛教內容已納入基礎衛教單，不另發個別衛教單

#	檢核項目	處置
5	服用肝酵素誘導劑（部分抗癲癇藥、聖約翰草等）	供藥 + 告知效果可能降低 + 詳細諮詢用藥 / 保健食品（台灣得在同意 + 持健保卡下查雲端藥歷核對）；不另設劑量調整。衛教內容已納入基礎衛教單，不另發個別衛教單
6	非通報之社會風險個案（脆弱家庭等）	供藥 + 於衛教單提供社福資源 QR Code，鼓勵自主聯繫（不強制轉介、不追蹤）
7	體重過重（>70kg / BMI>26）	供藥（本試辦僅 LNG）+ 告知高 BMI 可能降低效果。體重資料於線上問卷「選填」收集，未填不得拒絕供藥；有填答且超標者於個人化衛教清單加掛就醫轉介指引衛教單
8	血栓 / 子宮外孕病史 / PID	供藥 + 依「各情境對應之個人化衛教清單」加強對應提醒與追蹤衛教（血栓：用藥須較小心、應特別提醒；子宮外孕病史：務必回診追蹤 + 警訊衛教；PID：雙重避孕 + 性病防治衛教）
9	不願驗孕（階段一帶入）	供藥 + 依 3-1 完成四項告知 + 納入未就醫追蹤

皆「否」→ ● 給藥 + 一般衛教。

八、● 可供藥：標準衛教項目（系統依填答自動帶出個人化清單，藥師逐項確認）

- 盡速服用（越早效果越好）；不強制當場服用（願意者可當場服）。
- 服藥後短時間內（2-3 小時）嘔吐須補服。嘔吐補服快速通道詳 8-1。
- 常見副作用：月經提前 / 延後、點狀出血、噁心、頭痛。
- 警訊衛教**：月經延遲逾 1 週應驗孕；服藥後約 3 週建議驗孕或回診確認避孕成功；出現下腹劇痛或異常出血應立即就醫（子宮外孕警訊，發生率約萬分之一，惟延誤危險）。
- ECP 為補救措施、非常規避孕；提供常規避孕與雙重避孕衛教及銜接方式，明確告知「真正妥適的避孕方式是保險套 + 常規避孕藥之雙重避孕」。
- 哺乳中之服藥資訊**：可繼續哺乳；建議服藥前先哺乳、避免服後馬上哺乳。
- 併用肝酵素誘導劑（部分抗癲癇藥、聖約翰草等）之交互作用資訊**：效果可能降低；用藥中應告知醫師 / 藥師。
- 衛教單附社福資源與相關諮詢 QR Code。
- 依○、制度定位，告知「來得及就醫者仍建議由婦產科醫師評估」。

10. 藥師於系統逐項確認衛教完成 → 完成給藥紀錄、結案（防跨店重複購買）。

8-1 嘔吐補服快速通道

項目	規則
時間限定	24 小時內憑原條碼 / 原給藥紀錄回店
費用	須再收取一次費用（本項本即自費項目）
系統處理	藥師確認情節後以「補服代碼」記錄、免重新評估、不計入短期重複使用、跨店適用
併同提供轉介婦產科之選擇	嘔吐補服或建議轉介婦產科，提供補服之外的另一種選擇；補服流程須同時提供另一條就醫管道

轉介選擇之口頭說明要點：

1. 若嘔吐係藥物本身引起，再服一劑很可能再次嘔吐、甚至更嚴重。
2. 若嘔吐係其他原因引起，待狀況改善後再服或許無虞——惟須由醫師判斷。
3. 婦產科端可一併處理嘔吐問題，並告知其他可行的避孕方式。

各情境對應之個人化衛教清單（系統依填答自動帶出）

「基礎清單」= 上列 1-9 項（哺乳中與服用肝酵素誘導劑之資訊已納入基礎衛教單第 6、7 項，不另設個別衛教單）。實體衛教單共三種：①基礎衛教單（全員）、②社福資源衛教單（⑥-1 與 ⑥-6 共用同一份）、③就醫轉介指引衛教單（⑥-7 ~ ⑥-9、嘔吐補服等六情境共用同一份）；另 ⑥-2、⑥-3 之加值衛教維持個別內容。系統依線上填答與現場評估結果，於基礎清單上自動加掛對應衛教單與提醒（連動資訊系統功能 B-6「個人化衛教清單」）。

情境（處置結果）	衛教清單內容
● 一般供藥	基礎清單 1-9（全員必做；已含哺乳、肝酵素誘導劑資訊）
● 疑似性暴力 / 性侵害（⑥-1）	基礎清單 + 社福資源衛教單（113 通報與一站式服務流程說明〔就醫會經歷什麼、社工陪同〕、保留證據提醒、心理支持資源；與 ⑥-6 共用同一份）
● 性傳染病風險（⑥-2）	基礎清單 + 性病篩檢衛教（建議婦產科篩檢項目、windows period 概念）+ 保險套正確使用
● 短期重複使用（⑥-3）	基礎清單 + 強化常規避孕衛教（LARC 等選項比較、轉介婦產科避孕諮詢）+ 月經紊亂預期說明 + 追蹤說明
● 哺乳中（⑥-4）	基礎清單即可（哺乳資訊已納入基礎衛教單第 6 項，不另加掛）

情境（處置結果）	衛教清單內容
● 服用肝酵素誘導劑（⑥-5）	基礎清單即可（交互作用資訊已納入基礎衛教單第 7 項，不另加掛）
● 非通報之社會風險個案（⑥-6）	基礎清單 + 社福資源衛教單（與 ⑥-1 共用同一份；藥師引導：QR Code 內容逐項說明、鼓勵自主聯繫）
● 體重過重（⑥-7，僅有填答者）	基礎清單 + 就醫轉介指引衛教單（口頭併告知：效果可能降低）
● 血栓病史（⑥-8）	基礎清單 + 就醫轉介指引衛教單（口頭併提醒：用藥須較小心、應特別提醒）
● 子宮外孕病史（⑥-8）	基礎清單 + 就醫轉介指引衛教單（口頭併強化：子宮外孕警訊、「務必回診追蹤」之明確叮嚀）
● PID 病史（⑥-8）	基礎清單 + 就醫轉介指引衛教單（口頭併強化：雙重避孕〔保險套 + 常規避孕藥〕與性病防治衛教）
● 不願驗孕（⑥-9）	基礎清單 + 就醫轉介指引衛教單（口頭併完成 3-1 之四項告知） + 納入未就醫追蹤
● 嘔吐補服（8-1）	基礎清單 + 就醫轉介指引衛教單（口頭併說明轉介婦產科之選擇：再服可能再吐、可一併處理嘔吐、可討論其他避孕方式）
● 不供藥、直接轉介	無供藥衛教；改為 就醫指引 （轉介事由說明、就醫時效急迫性〔UPA≤120h / 含銅 IUD≤5 日〕、就醫會經歷什麼） + 轉介單 + 納入未就醫追蹤
● 不符本人親領	替代途徑告知 （現行就醫程序、時效急迫性） + 記錄已告知時間